胃食管反流病 ★★★（0~3 题）

- 病因（2013）
  - LES 障碍
    - 食管裂孔疝、贲门失弛缓症术后、胃 / 腹内压增高、高脂食物、某些激素和药物等
      “记少不记多：胃泌素等 + 治疗药物不会导致 LES 压力降低”
  - 食管清除作用降低：食管裂孔疝、干燥综合征（2019）
  - 食管黏膜屏障功能降低：NSAIDs 等
- 表现
  - 反复反流、烧心，多在餐后、卧位、弯腰加重
    可能可能最可能（2008、2012、2017）
  - ①食管症状（2007）：反流、烧心、胸痛、吞咽困难、胸骨后异物感
    ②食管外症状（2009、2020）：牙蚀症、癔球症、咽喉炎、声嘶、咳嗽、哮喘、吸入性肺炎、肺纤维化
  - 酷似心绞痛（纵隔胸痛、均可放射，2011、2012），但多为刺痛
  - 并发症
    “上下班”
    （2021、2022）
    - 上消化道出血
    - 食管狭窄
    - Barrett 食管：柱状上皮取代鳞状上皮（腺上皮化生），定期胃镜随访（食管腺癌的基础）
- 金标准：食管反流监测如 pH 监测（明确过度酸碱反流，2016）
  - 胃镜见食管黏膜破损→ RE
    “我气我”
    - A 级：破损＜ 5mm
    - B 级：破损＞ 5mm
    - C 级：破损融合＜ 75% 食管周径
    - D 级：破损融合＞ 75% 食管周径
  - 胃镜食管阴性 + 食管反流监测 +PPI 试验性治疗有效→ NERD
- 治疗（2026）
  - 长期维持治疗：食管狭窄、Barrett 食管、停药后症状很快复发且持续、重度食管炎（C 和 D 级）“下班负重”
  - 首选、最佳、维持治疗（2008、2017、2023、2025）：PPI（奥美 / 兰索 / 泮托拉唑）
  - P-CAB（伏诺拉生）、H2-RA（法莫 / 西咪替丁）、抗酸药（铝剂）、促胃肠动力药（莫沙必利）